

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA — CONTROL PRENATAL

Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo (sintético) — Consultorio Obstetricia

FILIACIÓN

Nombre:	Lucía Mendoza Quispe (SINTÉTICA - NO REAL)
DNI:	47812936
HC:	HCL-2024-08847
Edad:	28 años
Fecha consulta:	19/08/2024

ANTECEDENTES (resumen de controles previos)

Fórmula obstétrica: G2 P1. Antecedente familiar DM2 (madre). Sobrepeso pre-gestacional (IMC 25.6). ****DIABETES GESTACIONAL**** diagnosticada en sem 24 (10/06/2024) por PTOG alterada. En dieta para diabéticas desde sem 24 con controles cada 2 semanas. Refiere que las glicemias capilares han aumentado en las últimas 2 semanas a pesar de adherencia estricta a la dieta.

GESTACIÓN ACTUAL

FUR:	27/12/2023
FPP:	03/10/2024
EG actual:	32 semanas + 4 días
Controles prenatales:	8 al momento
Movimientos fetales:	Presentes, percibidos normalmente

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

Peso actual:	76.8 kg (ganancia total 12.8 kg)
PA:	122/78 mmHg
FC:	86 lpm
AU:	33 cm (1 cm por encima de EG)
FCF:	144 lpm
Edemas:	Pretibiales +/- (leves)

AUTOMONITOREO DE GLICEMIAS (últimas 2 semanas)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Glicemia basal — promedio	102	mg/dL	ALTERADO (objetivo <95)
Glicemia 1 h post-prandial — promedio	145	mg/dL	ALTERADO (objetivo <140)
HbA1c	6.2	%	Alto para embarazo (objetivo <6.0)

ECOGRAFÍA DE CONTROL (sem 32)

Feto único vivo en presentación cefálica. Peso fetal estimado: 2,100 g (percentil 85 — TENDENCIA A MACROSOMÍA). Anatomía conservada. Líquido amniótico: ILA 22 cm (POLIHIDRAMNIOS leve — asociado a DG). Doppler umbilical normal. Placenta corporal anterior, grado II.

OTROS LABORATORIOS

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Urocultivo	Negativo	—	Sin crecimiento

Proteinuria cualitativa	Negativo	—	Sin proteinuria
-------------------------	----------	---	-----------------

DIAGNÓSTICO

1. Embarazo de 32 semanas + 4 días. 2. ****Diabetes gestacional MAL CONTROLADA con dieta**** (HbA1c 6.2%, glicemias ayunas promedio 102 mg/dL, post-prandiales 145 mg/dL). 3. ****Macrosomía fetal incipiente**** (PFE p85). 4. ****Polihidramnios leve**** (ILA 22 cm).

PLAN

1. ****INICIO DE INSULINA NPH**** 10 UI subcutáneas en la noche (antes de cenar). 2. Reforzar dieta para diabéticas con énfasis en fraccionamiento adecuado. 3. Aumentar ****automonitoreo a 6 controles diarios**** (basal + pre-prandial + 1 hora post-prandial x 3 comidas). 4. Reevaluación en ****1 semana**** para titulación de dosis de insulina según respuesta glicémica. 5. ****Ecografía de control en sem 36**** para reevaluación de peso fetal. 6. ****Conteo diario de movimientos fetales**** (al menos 10 mov/2 h en periodos de actividad). 7. Refuerzo de signos de alarma: hipoglucemia severa, ausencia de movimientos fetales, sangrado, pérdida de líquido amniótico, contracciones regulares.

Médico tratante: Dr. Juan Carlos Vásquez Torres — CMP 45821

Documento generado para fines de prueba del clinical-extractor de SICA. Sintético. No representa una paciente real.